

SCANNER & IRM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Centre d'Imagerie Médicale
45 avenue Rockefeller
69008 LYON
Résultats : imagerie-aura.fr
Téléphone : 04.78.00.00.00

Nom : RENAUD
Prénom : Philippe
Date de naissance : 11/12/1972
Sexe : M

Lyon, le 24/04/2026

Dr Claire VINCENT
Médecin radiologue

SCANNER ABDOMINO-PELVIEN

Indication :

Douleur épigastrique aiguë irradiant dans le dos, associée à des vomissements et une élévation des lipases. Suspicion de pancréatite aiguë.

Technique :

Acquisition tomодensitométrique abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisitions aux temps artériel et portal.
Reconstructions multiplanaires.
Analyse en fenêtres parenchymateuse, vasculaire et digestive.

Résultats :

Pancréas :

Augmentation globale de volume du pancréas, à contours flous.
Hétérogénéité du rehaussement parenchymateux, avec des zones hypo-rehaussées au niveau du corps et de la queue, évoquant des plages de nécrose débutante.

Importante infiltration de la graisse péri-pancréatique avec épaissement des fascias adjacents.

Présence de coulées liquidiennes péri-pancréatiques s'étendant vers les espaces para-rénaux antérieurs et la racine du mésentère.

Collections :

Présence de collections liquidiennes mal limitées péri-pancréatiques, sans paroi organisée, compatibles avec des collections aiguës.

Pas de collection encapsulée ni d'abcès constitué identifiable à ce stade.

Voies biliaires et vésicule biliaire :

Présence de multiples microlithiases vésiculaires.

Discrète dilatation de la voie biliaire principale mesurée à 9 mm.

Pas de calcul clairement individualisé dans la voie biliaire principale.

Foie :

Foie de taille normale, sans lésion focale suspecte.

Rate :

Rate homogène, de taille normale.

Surrénales :

Sans anomalie.

Reins et espaces rétro-péritonéaux :

Reins de morphologie normale.

Infiltration des espaces para-rénaux antérieurs en rapport avec la pancréatite.

Vaisseaux :

Perméabilité conservée de la veine porte et de la veine splénique.

Pas de thrombose veineuse visible.

Pas de pseudo-anévrisme identifié.

Cavité péritonéale :

Présence d'un épanchement péritonéal modéré.

Structures osseuses :

Pas d'anomalie suspecte.

Conclusion :

Aspect de **pancréatite aiguë nécrosante**, avec plages de nécrose pancréatique et importantes coulées inflammatoires péri-pancréatiques.

Absence d'abcès constitué ou de collection encapsulée à ce stade.

Présence de microlithiasés vésiculaires avec discrète dilatation de la voie biliaire principale, évoquant une **étiologie biliaire probable**.

Recommandations :

Prise en charge en milieu spécialisé avec surveillance rapprochée.

Suivi scanographique recommandé pour évaluation de l'évolution des zones de nécrose et des collections.

Discussion d'une prise en charge biliaire (échoendoscopie / CPRE) en fonction de l'évolution clinique et biologique.